

CATATONIA — RECONHECER + LORAZEPAM

SINAIS CARDINAIS DA CATATONIA

Sinal	Descrição
Estupor / mutismo	Ausência de resposta e de fala, com vigília
Catalepsia / flexibilidade cêrea	Manutenção de posturas impostas; resistência plástica ('cera')
Negativismo	Resistência ou oposição a comandos/estímulos
Posturas/maneirismos/estereotípias	Posturas bizarras mantidas, movimentos repetitivos
Ecolalia / ecopraxia	Repetir falas / imitar movimentos do examinador
Agitação catatônica	Agitação intensa e sem propósito (forma excitada)

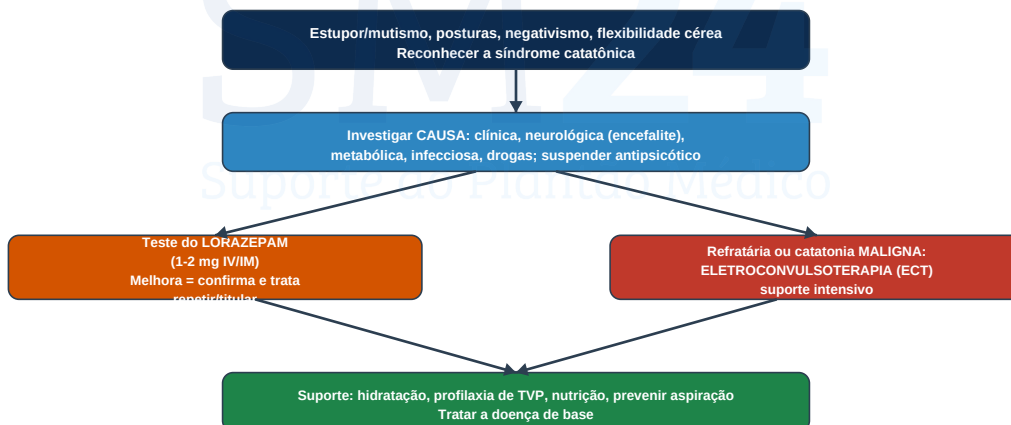
CATATONIA NÃO É SÓ PSIQUIÁTRICA

PROCURAR CAUSA ORGÂNICA E A FORMA MALIGNA

- Causas: transtornos do humor (a mais comum), esquizofrenia, mas também CAUSAS ORGÂNICAS (encefalite — inclusive anti-NMDA, distúrbios metabólicos, infecções, drogas)
- Sempre investigar causa clínica/neurológica — não assumir que é apenas psiquiátrica
- Teste diagnóstico-terapêutico: LORAZEPAM (resposta rápida confirma e trata a catatonia)
- Catatonia MALIGNA: febre, instabilidade autonômica e rigidez — emergência com risco de vida (semelhante à síndrome neuroléptica maligna)
- EVITAR antipsicóticos na catatonia (podem piorar e precipitar a forma maligna/SNM)
- Complicações do imobilismo: TVP/TEP, desidratação, broncoaspiração, úlcera, rabdomiólise

ABORDAGEM DA CATATONIA

CATATONIA — INVESTIGAR + LORAZEPAM



CATATONIA MALIGNA vs SÍNDROME NEUROLÉPTICA MALIGNA

Aspecto	Catatonia maligna	SNM
Gatilho	Catatonia que evolui com febre/disautonomia	Início/aumento de antipsicótico (bloqueio dopaminérgico)
Quadro	Rigidez, febre, instabilidade autonômica, alteração da consciência	Rigidez 'em cano de chumbo', febre, disautonomia, CK elevada
Sobreposição	Compartilham muitos sinais — podem ser um continuum	Considerada por alguns uma forma de catatonia maligna induzida por droga
Antipsicótico	Evitar / suspender	Suspender imediatamente
Tratamento	Benzodiazepínico e ECT; suporte	Suspender o agente + suporte; dantroleno/bromocriptina; ECT se refratária
Comum a ambas	Emergência com risco de vida; suporte intensivo	Emergência com risco de vida; suporte intensivo

TRATAMENTO E SUPORTE

Lorazepam e ECT

- Lorazepam 1-2 mg IV/IM como teste; melhora dramática confirma e trata
- Manter/titular o benzodiazepínico conforme a resposta
- Eletroconvulsoterapia (ECT): tratamento de escolha na catatonia refratária e na maligna
- Evitar antipsicóticos (risco de piora e de SNM)
- Tratar a doença de base (humor, psicose, causa orgânica)
- Resposta ao lorazepam costuma ser rápida

Cuidados de Suporte

- Hidratação e nutrição (risco de desidratação e desnutrição pelo imobilismo)
- Profilaxia de TVP/TEP
- Prevenção de broncoaspiração e úlcera de pressão
- Monitorar CK (rabdomiólise) e função renal na forma maligna
- Vigilância de sinais autonômicos (febre, PA, FC)
- Investigar e tratar a causa orgânica quando presente

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Reconhecer os sinais cardinais (estupor, mutismo, catalepsia, negativismo, flexibilidade cérea)
- ☐ Investigar causa clínica/neurológica (encefalite, metabólica, infecção, drogas) — não assumir só psiquiátrica
- ☐ Teste do lorazepam (1-2 mg): melhora confirma e trata a catatonia
- ☐ EVITAR antipsicóticos (risco de piora e de catatonia maligna/SNM)
- ☐ Catatonia maligna (febre + disautonomia + rigidez) ou refratária: ECT + suporte intensivo
- ☐ Suporte: hidratação, profilaxia de TVP, nutrição, prevenção de aspiração; tratar a doença de base

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com mutismo, imobilidade e flexibilidade cérea (mantém posturas impostas). Qual teste diagnóstico-terapêutico deve ser realizado?

- A) Teste com haloperidol
- B) Teste com lorazepam (melhora confirma e trata a catatonia)
- C) Teste com naloxona
- D) Teste com flumazenil
- E) Teste com cetamina

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que se deve EVITAR antipsicóticos no manejo da catatonia?

- A) Porque não têm efeito sedativo
- B) Porque podem piorar a catatonia e precipitar a forma maligna / síndrome neuroléptica maligna
- C) Porque causam hipertensão
- D) Porque aceleram a recuperação
- E) Porque são contraindicados apenas em idosos

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o tratamento de escolha para a catatonia refratária ao benzodiazepínico ou para a catatonia maligna?

- A) Antipsicótico em alta dose
- B) Eletroconvulsoterapia (ECT)
- C) Lítio
- D) Antidepressivo tricíclico
- E) Contenção mecânica isolada

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Além das causas psiquiátricas, o que sempre deve ser investigado na catatonia?

- A) Apenas o histórico familiar
- B) Causas orgânicas (encefalite, distúrbios metabólicos, infecções, drogas)
- C) Somente o uso de cafeína
- D) Apenas o sono
- E) Nada, é sempre psiquiátrica

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Paciente catatônico evolui com febre alta, rigidez e instabilidade autonômica. Qual quadro deve ser reconhecido?

- A) Catatonia maligna — emergência com risco de vida
- B) Resfriado comum
- C) Crise de ansiedade
- D) Enxaqueca
- E) Intoxicação por cafeína

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O teste do lorazepam (1-2 mg IV/IM) é diagnóstico-terapêutico na catatonia: a melhora, frequentemente dramática, confirma o diagnóstico e trata. Os benzodiazepínicos são a primeira linha de tratamento.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Os antipsicóticos devem ser evitados na catatonia porque podem piorar o quadro e precipitar a catatonia maligna / síndrome neuroléptica maligna (pelo bloqueio dopaminérgico). Prefere-se benzodiazepínico e, se necessário, ECT.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A eletroconvulsoterapia (ECT) é o tratamento de escolha para a catatonia refratária ao benzodiazepínico e para a catatonia maligna, com resposta frequentemente rápida e segura.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Embora as causas psiquiátricas (transtornos do humor, esquizofrenia) sejam comuns, deve-se sempre investigar causas orgânicas — encefalite (incluindo anti-NMDA), distúrbios metabólicos, infecções e drogas — que também causam catatonia.

QUESTÃO 5 → Resposta: A

Catatonia com febre, rigidez e instabilidade autonômica caracteriza a catatonia maligna — emergência com risco de vida (semelhante à síndrome neuroléptica maligna), que exige suporte intensivo, benzodiazepínico e ECT.

SM24
Suporte ao Plantão Médico